

First change is the color of use in the page, instead of blue please use Purple

Also use this logo in the homepage or in the software itself



System Architecture & Web Links

Link 1: Public Screening Portal (Searchable on Browsers)

- Accessible to anyone on the internet.
- Houses the educational landing page and the two assessment tracks.
- **Data Behavior:** Family track data is processed instantly on-screen and **not saved** to the database to comply with Data Privacy laws. Medical track data is securely transmitted to Link 2 upon submission.

Link 2: Clinical Central Dashboard (Restricted Access)

- Limited access to those who have links.
- **Data Behavior:** Automatically populates with the demographic profile, MoCA-P breakdown, Katz scores, interpretation, and date of assessment *only* from the Medical Professional track.
- Features filtering tools (by Patient ID, Age, or Diagnostic Category) and a "**Download PDF Report**" button for clinical files.

Link 1: Main Homepage Layout

- **Top Navigation Bar:**
 - App Logo (**DementiAware**)
 - Language Toggle Button: [English | Filipino] (*Changes all text, trivia, and test questions and interpretations instantly without reloading the page*)

- **Remain Body Content (Dementia Trivia Hub):**
 - Dynamic trivias (e.g., *"Did you know? Dementia is not a normal part of aging." / "Alam mo ba? Ang dementia ay hindi natural na bahagi ng pagtanda."*)
 - **Primary Action Buttons:**
 - [What is Dementia?] Opens an informational popup/modal or scrolls down to the trivia section.
 - [Take the Assessment Test] Triggers a dynamic overlay revealing two choice buttons:
 1. [Medical Professional / Trained Specialist]
 2. [Family Member / Caregiver]
-

Track A: Medical Professional Workflow

Part 1: Demographic Profile (Data Inputs Needed)

Developer must map these exact form fields into the database:

1. **Patient ID / Case Number** (*Text - to protect anonymity if preferred*)
2. **Full Name** (*Text - optional, based on institutional choice*)
3. **Age** (*Number*)
4. **Sex assigned at birth** (*Radio button: Male / Female*)
5. **Years of Formal Education** (*Dropdown Selector - **Crucial for scoring Logic***):
 - [12 years or fewer (High School Graduate or below)] *Triggers +1 bonus point on MoCA-P calculation.*
 - [More than 12 years (College Level or Graduate)] *Adds 0 points.*
6. **Clinician Name/ID** (*Text - logs who administered the test*)

Part 2: MoCA-P Assessment (30 Points Max)

- **UI Structure:** 3-Section Split Screen layout for each question. (Item | guide/ instruction | Score)
- **Content:** 7 domains (Visuospatial, Naming, Attention, Language, Abstraction, Delayed Recall, Orientation).

- **Database Mapping:** Each domain must store its individual sub-score so it can be charted later.

Part 3: Katz ADL Test (6 Points Max)

- 6 items: Bathing, Dressing, Toileting, Transferring, Continence, Feeding.
- **Input:** Binary radio buttons for each item: [1 = Independent] or [0 = Dependent].

Post-Submission Screen (Medical View)

Upon clicking [Submit Assessment], the data is sent to the **Clinical Dashboard (Link 2)** and displays this summary to the doctor:

- **Total Scores:** Final Adjusted MoCA-P Score (out of 30) & Katz ADL Score (out of 6).
 - **Domain Breakdown:** List of how the patient scored in each MoCA-P domain.
 - **Clinical Interpretation:** Displays the exact classification (Normal / MCI / Moderate Dementia / Severe Dementia).
 - **Action or Referral:** Clinical recommendation text (e.g., *"Flagged for early cognitive decline. Cross-reference with functional scores. Schedule 6-month follow-up."*)
 - **Print/Export:** A button to instantly print or download the page as a structured PDF.
-

Track B: Family / Caregiver Workflow

Part 1: Demographic Profile (Simplified)

1. **Patient's Initial or Nickname** (*Text - keeps data completely private on a public browser*)
2. **Patient's Age** (*Number*)
3. **Patient's Sex** (*Radio button: Male / Female*)
4. **Your Relationship to the Patient** (*Dropdown: Spouse, Child, Sibling, Professional Caregiver, etc.*)

Part 2: Mini-Cog Assessment (5 Points Max)

- **Step 1: 3-Word Registration:** Caregiver reads 3 words to the patient.
- **Step 2: Clock Drawing Test:** Instructions for the patient to draw a clock face pointing to 11:10. Caregiver scores it as [2 points = Normal Clock] or [0 points = Abnormal Clock].
- **Step 3: 3-Word Recall:** Caregiver asks the patient to repeat the words. Caregiver checks boxes for correct answers [0 to 3 points].

Part 3: Lawton IADL Test (8 Points Max for Women / 5 Max for Men)

- Tracks 8 instrumental skills (Phone use, Shopping, Food prep, Housekeeping, Laundry, Transit, Meds, Finances).
- **Input:** Multi-choice radio buttons mapped to: [1 = Independent] or [0 = Dependent] tailored to the patient's biological sex.

Post-Submission Screen (Caregiver View)

*This data is purely displayed on-screen and **never** pushed to the medical professional's private dashboard.*

- **Total Scores:** Mini-Cog Score (0–5) & Lawton Scale Summary.
 - **Interpretation (Bilingual):**
 - *English:* "Further medical evaluation recommended" OR "Low risk of cognitive impairment."
 - *Filipino:* "Kinakailangan ng karagdagang pagsusuri ng doktor" OR "Mababang panganib sa pagkaulianin."
 - **Action or Referral:**
 - **If patient has the interpretation of** Further medical evaluation recommended" OR "Low risk of cognitive impairment."
 - *English:* "Schedule an appointment with a Neurologist or Geriatrician. Take a screenshot or print this page to show them."
 - *Filipino:* "Mag-iskedyul ng patingin sa isang Neurologist o Geriatrician. Kuhanan ng larawan (screenshot) o i-print ang pahinang ito para ipakita sa doktor."
 - If the patient is in low risk just suggest retake after few weeks if necessary
 - **Summary Box:** A clean bulleted checklist summarizing what specific daily tasks the patient struggles with, making it easy for the family to explain the situation to a doctor.
-

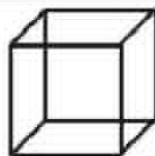
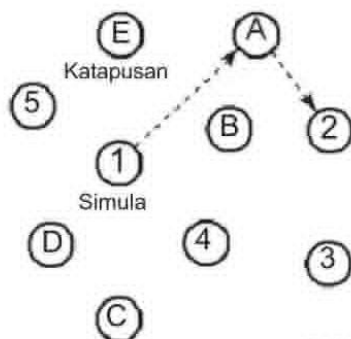
MoCA-P

MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT - PHILIPPINES (MOCA-P)

PANGALAN :
Edukasyon:
Kasarian :

Kaarawan:
PETA:

VISUOSPATIAL / EXECUTIVE



Kopyahin

Gumuhit ng ORASAN (sampung minuto makalipas ang alas onse) (3 points)

PUNTOS

[]

[]

[]

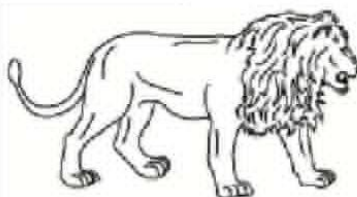
[]

[]

[]

/5

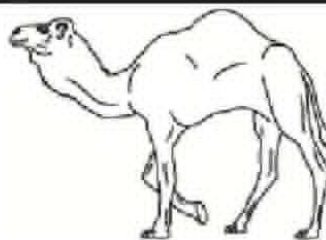
NAMING



[]



[]



[]

/3

MEMORY

Basahin ang listahan ng mga salita. Dapat maulit ng sinusuri ang mga ito. Gawing 2 pagsubok kahit nagtagumpay sa pang-una. Gawin ang naantalang pag-alala pagkaraan ng 5 minutos.

	MUKHA	ASUL	SIMBAHAN	ROSAS	SEDA
Pagsubok 1					
Pagsubok 2					

Walang puntos

ATTENTION

Basahin ang mga numero. (1 numero / segundo)

Dapat ulitin ng sinusuri ang mga numero eksakto ayon sa pagkakabigkas [] 2 1 8 5 4
Dapat ulitin ng sinusuri ang mga numero ng pabaliktad [] 7 4 2

/2

Basahin ang mga letra. Dapat tumapik ang sinusuri sa mesa sa bawat bigkas ng letra "A". Walang puntos ≥ 2 mali.

[] FBACMNAAJKLBAFAKDEAAAJAMOF AAB

/1

Bawasan ng 7 ang 100

[] 93 [] 86 [] 79 [] 72 [] 65
4 o 5 na tamang sagot=3 puntos; 2 o 3 tama=2 puntos; 1 tama=1 puntos; 0 tama=0 puntos

/3

LANGUAGE

Ulitin: Ang alam ko lang, si Juan ang siyang tutulong ngayong araw. []
Ang pusa ay palaging nagtatago sa ilalim ng supa kapag nasa kuwarto ang mga aso. []

/2

Katatanan / Magsabi sa loob ng 1 minuto ng mga salitang Filipino na nagsisi mula sa letrang B. [] _____ (N ≥ 11 salita)

/1

ABSTRACTION

Halimbawa: Pagkakapareho ng orange at saging = prutas [] tren - bisikleta [] timbangan - ruler

/2

DELAYED RECALL

Dapat matandaan ang mga salita ng walang tako o 'cue'

MUKHA	ASUL	SIMBAHAN	ROSAS	SEDA
[]	[]	[]	[]	[]

Bigyan ng puntos lamang ang mga salitang natandaan ng walang tako o 'cue'

/5

Opsyonal

Kategoryang tako
Maramihang pagpipilian

ORIENTATION

[] Petsa [] Buwan [] Taon [] Araw [] Lugar [] Lungsod

/6

© Z.Nasreddine MD

Version 7.1

www.mocatest.org

Normal $\geq 26 / 30$

TOTAL

/30

Philippine Version 4 March 2011

Adapted by Dominguez JC and the Dementia Study Group

Administered by: _____

Magdagdag 1 puntos kapag ≤ 12 yr edu

Montreal Cognitive Assessment – Philippines (MoCA-P)

Instruksiyon sa Pangangasiwa at Pagpupuntos

Ang Montreal Cognitive Assessment (MoCA) ay dinesenyo na mabilisang instrumento para sa pagsuri ng kaunting panghina ng katalusan. Sinusuri nito ang iba't ibang uri ng dominyo ng katalusan. Sinusuri nito ang atensyon at konsentrasyon, ehekutibong tungkulin, memorya, wika, visuoconstructional na kasanayan, konseptwal na pagiisip, kalkulasyon, at oryentasyon. Ang pagbigay ng MoCA-P ay humigit kumulang na sampung minutos. Ang total na posibleng iskor ay tatlong puntos; ang iskor na dalawampung anim o pataas ay itinuturing na normal.

1. Paggawa ng Palitang Tugaygayan [Alternating Trail Making]:

Pangangasiwa: Ang tagasuri ay magsasabi sa sinusuri: *"Gumuhit ng linya mula sa numero papunta sa letra ayon sa tamang pagkaka sunod sunod. Magumpisa dito [ituro ang number "1"]]; gumuhit ng linya mula 1 papunta sa letter A, pagkatapos papunta sa number 2 at ipagpatuloy tuloy. Magtapos dito [ituro ang (E)]."*

Pagpupuntos: Magbigay ng isang puntos kapag ang sinusuri ay matagumpay na gumuhit alinsunod sa padron: 1-A-2-B -3-C-4 -D -5 -E, at walang ginuhit na kahit anong linyang tumawid sa iba. Ano mang pagkakamali na hindi kaagad naitama ay walang puntos o 0.

2. Visuoconstructional na Kasanayan (Kubo) [Visuoconstructional Skills (Cube)]:

Pangangasiwa: Ang tagasuri ay sasabihin ang susunod na instruksiyon, habang itinuturo ang **kubo**: *"Kopyahin ng tama ang nakaguhit na ito, dito sa ibaba (ituro ang puwang sa baba ng kubo)".*

Pagpupuntos: Isang puntos ang ibigay sa tamang naisatuparang pagguhit.

- Ang pagguhit ay dapat tatlong-dimensiyonal
- Lahat ng linya ay naiguhit
- Walang linya na naidagdag
- Ang mga linya ay medyo magkahilera o parallel at ang kanilang haba ay pareho (tanggap ang rektanggulo na prisma)

Walang puntos na ibibigay kung may kahit isang hindi nasunod sa pamantayan sa itaas.

3. Visuoconstructional na Kasanayan (Orasan) [Visuoconstructional Skills (Clock)]:

Pangangasiwa: Ituro ang pangatlong kanang puwang at sabihin ang susunod na instruksiyon: *"Gumuhit ng orasan. Ilagay ang mga tamang numero at ilagay ang mga kamay ng orasan sa oras na sampung minuto makalipas ang alas onse."*

Pagpupuntos: Isang puntos ang ibigay para sa bawat na elemento alisunond sa pamantayan:

- Tabas (1 puntos): ang mukha ng relo ay dapat bilog, pwedeng tanggapin ang may konting pagkabaluktot; (halimbawa kaunting pagkulang sa pagsara ng bilog);

- Mga numero (1 puntos): lahat ng numero ng orasan ay dapat naroon at walang dagdag na numero; ang mga numero ay dapat nasa tamang pagkaka sunod sunod at nakalagay sa tinatayang kwadrante ng orasan; tanggap ang numero Roman; ang mga numero ay puwedeng nakalagay sa labas ng hugis bilog.
- Mga kamay (1 puntos): dapat mayroon dalawang kamay na parehong nagpapakita ng tamang oras; ang kamay na pang oras ay dapat kitang kita na mas maiksi kaysa kamay na pang minuto; ang mga kamay ay dapat nakagitna sa loob at ang kanilang salikup ay malapit sa gitna ng orasan.

Walang puntos na ibibigay sa anumang elemento kapag ang mga pamantayan ay hindi nasunod.

4. Pagpapangalan [Naming]:

Pangangasiwa: Magmula sa kaliwa, ituro ang bawat pigura at sabihin: "*Sabihin sa akin ang pangalan ng hayop na ito.*"

Pagpupuntos: Isang puntos ang ibigay para sa bawat susunod na sagot: (1) leon (2) kuwago (3) kamel o dromedary.

5. Memorya [Memory]:

Pangangasiwa: Ang tagasuri ay magbabasa ng listahan ng limang (5) salita sa bilis ng isang salita bawat isang segundo, pagkatapos sabihin ang susunod na instruksiyon: "*Ito ay isang pagsusuli ng memorya. Mayroon akong babasahin na listahan ng mga salita na kailangan mong tandaan. Makinig ng mabuti. Pagkatapos ko, sabihin mo sa akin ang lahat ng salitang iyong matandaan sa kahit anumang pagkakasunod.*" Markahan ng tsek (✓) sa inilaang espasyo ang bawat salita na natandaan dito sa unang pagsubok. Kapag ang sinusuri ay natapos na (natandaan ang lahat ng salita), o wala nang matandaan pa, basahin ang listahan ng pangalawang beses, sabihin ang susunod na instruksiyon: "*Babasahin ko muli ang parehong listahan ng mga salita ng pangalawang beses. Tandaan muli at sabihin sa akin lahat ng salitang iyong matandaan kasama ang mga nasabi mo na kanina.*" Markahan ng tsek (✓) sa inilaang espasyo ang bawat salita na natandaan dito sa pangalawang pagsubok. Pagkatapos, sabihin ang sinusuri na siya ay muling tatanungin sa kahulian ng test, sabihin: "*Tatanungin muli kita para sabihin ang mga salitang iyan sa kahulian ng test.*"

Pagpupuntos: Walang puntos na ibibigay para dito sa una at pangalawang pagsubok.

6. Atensyon [Attention]:

Pasulong na Digit Span (Forward Digit Span): Pangangasiwa: Sabihin ang susunod na instruksiyon: "*May sasabihin akong mga numero. Pagkatapos ko, ulitin mo ng eksakto ang mga ito katulad ng aking pagkakasabi.*" Basahin ang limang magkakasunod na numero sa bilis na isang digit bawat segundo.

Pabalik na Digit Span (Backward Digit Span): Pangangasiwa: Sabihin ang susunod na instruksiyon: *"Ngayon, may sasabihin ulit akong mga panibagong numero. Pagkatapos ko, sabihin mo sa akin ng pabaliktad."* Basahin ang tatlong magkakasunod na numero sa bilis na isang digit bawat segundo.

Pagpupuntos: Magbigay ng isang puntos sa bawat pagkakasunod na tamang naulit, (N.B.: ang tamang sagot para sa pabalik na pagsubok ay 2-4-7).

Kalistuhan (Vigilance): Pangangasiwa: Ang tagasuri ay babasahin ang listahan ng letra sa bilis na isa bawat segundo pagkatapos nyang sabihin ang susunod na instruksiyon: *"Magsasabi ako ng letrang magkakasunod sunod. Tuwing sasabihin ko ang letter A, tapikin mo ang lamesa ng isang beses. Kapag ibang letter ang aking sasabihin, huwag tumapik."*

Pagpupuntos: Magbigay ng isang puntos kapag wala o may isang mali (ang mali ay ang pagtapik sa maling letter o ang hindi pagtapik sa letter A).

Serial 7's: Pangangasiwa: Ang tagasuri ay magsasabi ng susunod na instruksiyon: *"Ngayon, bawasan ng pito ang one hundred. Sa bawat sagot, magbawas ka ng pito hanggang sabihin ko na tama na."* Sabihin ang instruksiyon ng dalawang beses kung kailangan.

Pagpupuntos: Itong item ay iniiskoran sa 3 puntos. Walang puntos (0) pag walang tama sa pagbawas, 1 puntos pag may isang tamang pagbawas, 2 puntos pag may dalawa- hanggang-tatlong tamang pagbawas, 3 puntos pag matagumpay na nakasagot ng apat o limang tamang pagbawas. Bilangin ang bawat tamang pagbawas ng 7 magmula sa 100. Ang bawat pagbawas ay suriing mag-isa; kung sumagot ng isang maling numero pero ang mga sumunod ay tama ang pagbawas ng pito, bigyan ng puntos ang mga tamang pagbawas. Halimbawa, ang sunusuri ay sumagot ng 92-85-78-71-64 kung saan ang "92" ay mali, ngunit lahat ng sumusunod na numero na nabawasan ng tama. Ito ay isang kamali lamang at nabibigyan ng tatlong puntos.

7. Pag-ulit ng Pangungusap [Sentence Repetition]:

Pangangasiwa: Ang tagasuri ay magsasabi ng susunod na instruksiyon: *"Magsasabi ako ng isang pangungusap. Pagkatapos ko, ulitin mong eksakto sa paraan ng aking pagkasabi [tigil]: Ang alam ko lang, si Juan ang siyang tutulong ngayong araw."* Pagkatapos ng sagot, sabihin: *"Ngayon magsasabi ako ng isa pang pangungusap. Ulitin mong eksakto sa paraan ng aking pagkasabi [tigil]: Ang pusa ay palaging nagtatago sa ilalim ng supa kapag nasa kuwarto ang mga aso."*

Pagpupuntos: Magbigay ng 1 puntos sa bawat pangungusap na naulit ng tama. Ang pagulit ay dapat eksakto. Maging alisto sa mga mali kagaya ng hindi sinabi (e.g., nawala ang "lang", "palagi") at mga pinalitan/dinagdagan (e.g., Si Juan ang siyang tumulong ngayon;" pinapalitan ang "nagtatago" ng "nagtago"; paghalinhin ng pangmarami, at iba pa).



8. Pasalitang Katatasan [Verbal Fluency]:

Pangangasiwa: Ang tagasuri ay magsasabi ng susunod na instruksiyon: "*Sabihin sa akin lahat ng maiisip mong salitang Filipino na nag-uumpisa sa isang letra na aking sasabihin mamaya. Pwede ang kahit anong salitang Filipino, ang hindi pwede ay mga pangalan ng tao o lugar (kagaya ng Pedro or Pangasinan), hindi pwede ang mga numero o mga salita na naguumpisa sa parehong tunog pero magkaiba ang dulo o hunlapi, halimbawa, sulat, sumulat, sumusulat. Sasabihin kitang huminto pagkatapos ng isang minuto. Handa ka na ba?*" [Tigil] "*Ngayon, magsabi ka ng mga salitang Filipino na nagsisimula sa letter B.*" [orasan hanggan 60 segundo]. "*Hinto.*"

Pagpupuntos: Magbigay ng isang puntos kung ang sinusuri ay nakabuo ng labing isang salita o mahigit pa sa loob ng 60 segundo. Isulat ang mga sagot sa ilalim o sa gilid ng papel.

9. Abstraksyon [Abstraction]:

Pangangasiwa: Ang tagasuri ay magtatanong sa sinusuri na ipaliwanag kung ano ang pagkakapareho ng bawat pares na bagay, umpisahan sa halimbawa: "*Sabihin mo sa akin kung papaano magkapareho ang orange at saging.*" Kung ang sinusuri ay sumagot sa kongkretong paraan, sabihin ng tagasuri sa isang karagdagan pagkakataon: "*Sabihin mo kung sa anong paraan pa sila magkapareho.*" Kung ang sinusuri ay hindi magbigay ng angkop na sagot (prutas), sabihin: "*Oo, at pareho silang prutas.*" Huwag magbigay ng anuman karagdagang instruksiyon o paglilinaw. Pagkatapos ng pagsanay, sabihin: "*Ngayon, sabihin mo sa akin kung papaano magkapareho ang tren at bisikleta.*" Pagkatapos ng sagot, ibigay ang pangalawang pagsubok, sabihin: "*Ngayon, sabihin mo sa akin kung papaano magkapareho ang ruler at timbangan*". Huwag magbigay ng karagdagan instruksiyon o senyas.

Pagpupuntos: Ang huling dalawang pares lamang ang bigyan ng puntos. Magbigay ng 1 puntos sa bawat isang tamang sagot. Ang mga susunod na sagot ay pwedeng tanggapin:

Tren-bisikleta = paraan ng transportasyon, paraan ng pagbiyahe, parehong makakapagpalakbay;

Ruler – timbangan = pangukat na instrumento, gamit na pangukat.

Ang mga susunod na sagot ay **hindi** tinatanggap: Tren-bisikleta=may gulong; Ruler – timbangan = parehong may numero.

10. Naantalang Pag-alaala [Delayed Recall]:

Pangangasiwa: Ang tagasuri ay magsasabi ng susunod na instruksiyon: "*Binasa ko sa yo kanina ang mga salita na dapat mong tandaan. Sabihin sa akin ang mga salitang iyong natatandaan.*" Lagyan ng tsek (✓) ang bawat tamang salita na kusang naalala ng walang tako o cue.

Pagpupuntos: **Magbigay ng isang puntos sa bawat salita na natandaan ng walang tako o cue.**

Opsyonal:

Pagkatapos ng naantalang pag-alaala, ibigay ng kategorya semantik na tako o cue na nakalaan sa ibaba para sa salitang hindi natandaan. Lagyan ng markang tsek (✓) sa nakatalagang lugar kung naalala ang salita sa tulong ng kategoryang tako, o sa tulong ng maramihang pagpipilihan o multiple-choice. Bigyan ng tako ang lahat ng salitang hindi naalala. Kung ang sinusuri ay hindi pa rin maalala pagkatapos ng kategoryang tako, bigyan siya ng maramihang pagpipilihan o multiple-choice, gamit ang susunod na halimbawang instruksiyon. "*Alin sa palagay mo ang salitang iyon, ILONG, MUKHA, o KAMAY?*"

Gamitin ang susunod na kategoryang tako o cue at maramihang pagpipilihan sa bawat salita:

	kategoryang tako o cue:	maramihang pagpipilihan o multiple choice:
MUKHA:	parte ng katawan	ilong, mukha, kamay
ASUL:	uri ng isang kulay	pula, asul, berde
SIMBAHAN:	uri ng gusali	simbahan, paaralan, pagamutan
ROSAS:	uri ng bulaklak	rosas, sampaguita, ilang-ilang
SEDA:	uri ng tela	maong, seda, pranela

Pagpupuntos: Walang puntos na ibibigay sa mga salitang naalala ng may tako o cue. Ang tako ay ginamit para lamang sa layuning impormasyon kliniko para mabigyan ang tagasuri ng karagdagan impormasyon tungkol sa uri ng sakit ng memorya. Para sa kakulangan sa memorya dahil sa problema sa retrieval, ito ay mapapabuti ng tako o cue. Para sa kakulangan sa memorya dahil sa problema sa enkwoding, hindi ito mapapabuti ng tako o cue.

11. Oryentasyon [Orientation]:

Pangangasiwa: Ang tagasuri ay magsasabi ng susunod na instruksiyon: "*Ano ang petsa ngayon?*" Kung ang sinusuri ay hindi makapagbigay ng kumpletong sagot, sabihin: "*Sabihin sa akin ang [taon, buwan, eksaktong petsa at araw ng linggo].*" Pagkatapos ay sabihin: "*Ngayon, sabihin sa akin kung nasa 'ang lugar ka ngayon at kung sa 'ang bayan, siyudad o munisipyo.*"

Pagpupuntos: Magbigay ng isang puntos sa bawat tamang sagot. Dapat masabi ang eksaktong petsa at eksaktong lugar (pangalan ng ospital, klinika, opisina). Walang puntos na ibibigay kung ang sinusuri ay nagkamali ng isang araw para sa araw at petsa.

TOTAL ISKOR: Pagsama-samahin ang lahat ng iskor na nakalista sa kanang bahagi. Magdagdag ng isang puntos kapag ang sinusuri ay may labing dalawang taon o mas kaunti na pormal na edukasyon. Ang total iskor na dalawampung anim at pataas ay itinuturing na normal.

MoCA-P English Guide

1. Visuospatial and Executive Functions (5 Points)

- **Alternating Trail Making (1 Point):**
 - *Instruction:* Tell the patient: "Please draw a line going from a number to a letter in ascending order. Start here at 1, draw a line to A, then to 2, and so on. End at E."
 - *Scoring:* **1 point** if they correctly connect the pattern 1-A-2-B-3-C-4-D-5-E without crossing lines. **0 points** if they make an error.
- **Cube Drawing (1 Point):**
 - *Instruction:* Point to the cube and say: "Please copy this drawing as accurately as you can in the space below."
 - *Scoring:* **1 point** if the drawing looks three-dimensional, all lines are present, and lines are relatively parallel.

- **Clock Drawing (3 Points):**

- *Instruction:* Say: "Please draw a clock face. Put in all the numbers and set the time to ten past eleven (11:10)."
- *Scoring:* Give **1 point for Contour** (must be a closed circle), **1 point for Numbers** (all 12 numbers must be in the correct sequence and quadrant), and **1 point for Hands** (two hands originating from the center pointing to 11 and 2, with the hour hand clearly shorter). 

2. Naming (3 Points)

- *Instruction:* Point to each localized animal drawing one by one and ask: "Tell me the name of this animal."
- *Scoring:* Give **1 point per animal** named correctly. 

3. Memory & Delayed Recall (5 Points)

- *Instruction:* Say: "This is a memory test. I am going to read a list of five words that you will have to remember. Listen carefully and repeat them back to me when I am through." Read the words at a rate of one per second: **"FACE, BLUE, CHURCH, ROSE, SILK"**. (In pure English tests, these are the standard words, but in the Philippine adaptation, they must be tested for recall after 5 minutes). Run a second trial to help them learn, but **do not score these initial trials**. Tell them: "*I will ask you to remember these words again at the end of the test.*"
- *Scoring:* At the end of the entire test, ask them to recall the words. Give **1 point for each word** remembered completely on their own without clues.  Geriatric Assessme... +3

4. Attention (6 Points)

- **Digit Span (2 Points):**

- *Instruction (Forward):* Say: "I am going to say some numbers. When I am through, repeat them exactly as I said them." Read: 2 – 1 – 8 – 5 – 4 .
- *Instruction (Backward):* Say: "Now I am going to say some more numbers, but when I am through, you must repeat them to me in the backward order." Read: 7 – 4 – 2 .
- *Scoring:* Give **1 point** for the correct forward repetition and **1 point** for the correct backward repetition.

- **Vigilance / Tapping (1 Point):**

- *Instruction:* Say: "I am going to read a sequence of letters. Every time I say the letter 'A', tap your hand once on the table. If I say a different letter, do not tap." Read the letter string clearly at a rate of one per second.
- *Scoring:* Give **1 point** if they make 0 or 1 error. Give **0 points** if they make 2 or more errors.

- **Serial 7s (3 Points):**

- *Instruction:* Say: "Now, I want you to count backward by subtracting 7 from the number 60, and keep subtracting 7 until I tell you to stop." (Note: Standard MoCA starts at 100, but **MoCA-P starts at 60**).
- *Scoring:* Give **3 points** for 4 or 5 correct subtractions. Give **2 points** for 2 or 3 correct subtractions. Give **1 point** for 1 correct subtraction. Give **0 points** for none.



5. Language (3 Points)

- **Sentence Repetition (2 Points):**

- *Instruction:* Say: "I am going to read you a sentence. Repeat it after me, exactly as I say it." Read: "The child walked his dog in the park after midnight." Then read the second sentence: "The cat always hid under the couch when dogs were in the room."
- *Scoring:* Give **1 point for each sentence** repeated perfectly with no omissions or substitutions.

- **Verbal Fluency (1 Point):**

- *Instruction:* Say: "I want you to tell me as many words as you can think of that begin with a certain letter of the alphabet that I will give you now. You can say any kind of word, except for proper nouns or numbers. You have one minute. The letter is 'B'." (Note: Standard MoCA uses 'F', but **MoCA-P uses 'B'** because it is a highly productive letter in the Philippine language system).
- *Scoring:* Give **1 point** if the patient names **11 or more words** in 60 seconds.  Geriatric Assessme... +2

6. Abstraction (2 Points)

- *Instruction:* Say: "Tell me how an orange and a banana are alike." If they answer incorrectly, prompt them: "They are both fruits." Then say: "Now tell me how a train and a bicycle are alike." Next, say: "Tell me how a ruler and a watch are alike."
- *Scoring:* Give **1 point per pair** for acceptable abstract categories (e.g., train/bicycle = means of transportation; ruler/watch = measuring instruments). Do not give points for surface-level descriptions (e.g., "they both have wheels").  TalkBank +1

7. Orientation (6 Points)

- *Instruction:* Ask the patient: "Tell me today's date, the month, the year, and the day of the week. Then, tell me the name of this place and the city we are in."
- *Scoring:* Give **1 point for each** correct answer. Responses must be exact.

Final Scoring & Diagnostic Thresholds

1. **Calculate the raw score:** Add up all the points earned across the 7 sections (Maximum of 30 points).
2. **Apply the Education Adjustment: Add exactly 2 points** to the score if the patient has **7 years or fewer** of formal education (did not progress past elementary school). The final score cannot exceed 30. 

Katz ADLs Assessment English Guide

LARS R. NEWSOME, MD

ASMG

Pain Management Office | 4130 La Jolla Village Drive, Suite 300 | La Jolla, CA 92037

KATZ BASIC ACTIVITIES OF DAILY LIVING (ADL) SCALE

Patient Name _____	Today's Date _____
--------------------	--------------------

ACTIVITIES POINTS (0 or 1)	INDEPENDENCE: (1 POINT) NO supervision, direction or personal assistance	DEPENDANCE: (0 POINTS) WITH supervision, direction, personal assistance or total care
BATHING POINTS: _____	(1 POINT) Bathes self completely or needs help in bathing only a single part of the body such as the back, genital area or disabled extremity.	(0 POINTS) Needs help with bathing more than one part of the body, getting in or out of the tub or shower. Requires total bathing.
DRESSING POINTS: _____	(1 POINT) Gets clothes from closets and puts on clothes and outer garments complete with fasteners. May have help tying shoes.	(0 POINTS) Needs help with dressing self or needs to be completely dressed.
TOILETING POINTS: _____	(1 POINT) Goes to toilet, gets on and off, arranges clothes, cleans genital area without help.	(0 POINTS) Needs help transferring to the toilet, cleaning self or uses bedpan or commode.
TRANSFERRING POINTS: _____	(1 POINT) Moves in and out of bed or chair unassisted. Mechanical transferring aides are acceptable.	(0 POINTS) Needs help in moving from bed to chair or requires a complete transfer.
CONTINENCE POINTS: _____	(1 POINT) Exercises complete self-control over urination and defecation.	(0 POINTS) Is partially or totally incontinent of bowel or bladder.
FEEDING POINTS: _____	(1 POINT) Needs partial or total help with feeding or requires parenteral feeding.	(0 POINTS) Needs partial or total help with feeding or requires parenteral feeding.

TOTAL POINTS = _____	6 = HIGH (patient independent) 0 = LOW (patient very dependent)
-----------------------------	--

Katz ADLs Assessment Tagalog

Gawain (Activity)	Independent (1 Puntos)	Dependent (0 Puntos)
1. Pagligo (<i>Bathing</i>)	Malinis ang buong katawan nang mag-isa.	Kailangan ng tulong sa paghugas ng katawan.
2. Pagbihis (<i>Dressing</i>)	Kayang kumuha at magsuot ng damit.	Hindi kayang magbihis nang walang tumutulong.
3. Paggamit ng Kubeta (<i>Toileting</i>)	Kayang pumunta, umupo, at maglinis sa banyo.	Kailangan ng alalay sa pagpunta at paglinis.
4. Paglipat ng Puwesto (<i>Transferring</i>)	Kayang bumangon sa kama o tumayo sa upuan.	Kailangan ng tulong para maiposisyon ang sarili.
5. Pagpigil sa Pagdumi/Pag-ihi (<i>Continence</i>)	May buong kontrol sa pag-ihi at pagdumi.	Madalas maihi o madumi sa kasuotan.
6. Pagkain (<i>Feeding</i>)	Kayang magsubo ng pagkain mula sa pinggan.	Kailangan subuan o lagyan ng tubo ang pagkain.

Katz ADLs Assessment Instructions

English

1. **Observe or Interview:** Evaluate the patient by observing their daily routine or by interviewing them, their family members, or primary caregivers.
2. **Rate Current Ability:** Score the patient based on their actual performance over the past 24 to 48 hours, not their potential ability.
3. **Apply Strict Scoring:** Award 1 point ONLY if the patient performs the task completely independently. Award 0 points if they require any form of human assistance, supervision, or verbal prompting.

Tagalog

1. **Mag-observa o Magtanong:** Suriin ang pasyente sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanilang kilos o pagtatanong sa kanila, sa pamilya, o sa kanilang tagapag-alaga.

2. **Ibase sa Kasalukuyang Kakayahan:** Bigyan ng marka ang pasyente ayon sa aktwal nilang ginawa sa nakalipas na 24 hanggang 48 oras, hindi sa kung ano ang "kaya" lang nilang gawin.
3. **Maging Mahigpit sa Pagpuntos:** Magbigay ng 1 puntos KUNG KAYA LANG nilang gawin ang buong aktibidad nang mag-isa. Magbigay ng 0 puntos kung kailangan nila ng anumang tulong, gabay, o paalala mula sa ibang tao.

MoCA-P and Katz ADLs Assessment Interpretation Guide

Tagalog

MoCA-P Score (Isip/Cognitive)	Katz Score (Pisikal/ADLs)	Interpretasyon sa Kalagayan ng Pasyente	Rekomendasyon at Aksyon / Referral
21 hanggang 30 (Normal)	6 / 6 (Ganap na Malaya)	Malusog na Pagtanda (Healthy Aging) Malinaw ang isip at kayang-kaya ang lahat ng pisikal na gawain nang mag-isa.	Karaniwang Pagsubaybay: Magbigay ng gabay sa kalusugan. Ulitin ang screening taon-taon o kung may bagong mapunang kakaiba sa pasyente.
21 hanggang 30 (Normal)	3 hanggang 5 (Bahagyang May Kahirapan)	Pisikal na Panghihina Lamang Malinaw at normal ang isip, ngunit nahihirapan sa ilang pisikal na kilos gaya ng pagligo o paglipat ng upuan.	Rehabilitasyon ng Katawan: I-refer sa Physical Therapist (PT) o Occupational Therapist (OT) para lumakas. Suriin ang bahay upang maiwasan ang pagkadulas o pagkatumba.
21 hanggang 30 (Normal)	2 o mas mababa (Malalang Kahirapan)	Malalang Kapansanan sa Pisikal Normal ang takbo ng isip ngunit lubos na umaasa sa iba para sa pisikal na pangangailangan (gaya ng may malalang rayuma o na-stroke).	Pangmatagalang Pag-aalaga: I-refer sa mga Home Health Care Services o Social Worker para sa paggabay sa tagapag-alaga. Maghanda ng mga assistive device tulad ng wheelchair o walker.
20 o mas mababa (May Kakulangan)	6 / 6 (Ganap na Malaya)	Maagang Senyales ng Pagkaulyanin / MCI Pasok sa DOST-PCHRD criteria ng maagang paghina ng isip, ngunit kaya pa ang pisikal na pag-aalaga sa sarili.	Pagsusuri sa Utak at Nerbyos: I-refer sa Neurologist o Geriatric Psychiatrist para sa mas malalim na pagsusuri. Magpasuri ng dugo (TSH, B12, CBC). Paalalahanan ukol sa kaligtasan sa pagmamaneho o pag-inom ng gamot.
20 o mas mababa (May Kakulangan)	3 hanggang 5 (Bahagyang May Kahirapan)	Pagkaulyanin na May Epekto sa Kilos May senyales ng Alzheimer's o dementia na nagsisimula nang makagulo sa ligtas at malayang pag-aalaga sa sarili.	Paggabay ng Geriatric Doctor: I-refer sa isang Geriatrician (doktor sa matatanda) para sa angkop na gamot. Kumonsulta sa Occupational Therapy (OT) upang gumawa ng simpleng rutina at gabay sa loob ng bahay.
20 o mas mababa (May Kakulangan)	2 o mas mababa (Malalang Kahirapan)	Malalang Paghina ng Isip at Katawan Magkasabay na malalang pagkaulyanin at kawalan ng kakayahang kumilos o mabuhay nang walang nag-aalaga.	Palliative Care at Puspulang Pag-aalaga: Agaring i-refer sa isang Multidisciplinary Geriatric Palliative Team o Memory Care Facility. Kailangan ng 24/7 na pagbabantay, pag-aayos ng legal na dokumento (Power of Attorney), at suporta sa pamilyang nag-aalaga upang maiwasan ang labis na pagkapagod (burnout).

English

MoCA-P Score (Cognitive)	Katz Score (Physical ADLs)	Overall Clinical Interpretation	Action & Recommended Referral
21 to 30 (Normal)	6 / 6 (Fully Independent)	Healthy Aging Cognitively intact and completely physically independent.	Routine Monitoring: Provide preventative wellness education. Re-screen annually or if new complaints surface.
21 to 30 (Normal)	3 to 5 (Moderate Impairment)	Isolated Physical Deconditioning Intact mental clarity but struggles with specific physical tasks (e.g., bathing, transferring).	Physical Rehabilitation: Refer to Physical Therapy (PT) or Occupational Therapy (OT) to regain strength. Request a home safety assessment to prevent falls.
21 to 30 (Normal)	2 or less (Severe Impairment)	Severe Physical Disability Preserved cognitive function alongside profound physical dependence (e.g., advanced arthritis, stroke deficits).	Long-Term Care Support: Refer to Home Health Care Services and social workers for full caregiver placement. Order specialized assistive devices and mobility aids.
20 or below (Impaired)	6 / 6 (Fully Independent)	Early Cognitive Decline / Mild MCI Meets DOST-PCHRD criteria for probable cognitive impairment, but retains independent physical functioning.	Neurological Diagnostic Panel: Refer to a Neurologist or Geriatric Psychiatrist for a comprehensive workup. Order baseline labs (TSH, B12, CBC). Initiate driving and medication safety counselling.
20 or below (Impaired)	3 to 5 (Moderate Impairment)	Cognitive Decline with Functional Deficits Signs of dementia or progressing Alzheimer's beginning to interfere with safe, independent daily self-care.	Geriatric Co-Management: Refer to a Geriatrician for pharmacological evaluation (e.g., cholinesterase inhibitors). Engage Occupational Therapy (OT) to implement highly structured behavioral cues and functional adaptation routines at home.
20 or below (Impaired)	2 or less (Severe Impairment)	Advanced Neurodegenerative State Severe co-occurring cognitive decline and total dependency across basic survival tasks.	Comprehensive Care & Palliative Services: Immediate referral to a Multidisciplinary Geriatric Palliative Team or memory care institution. Implement 24/7 supervision, establish legal power of attorney/proxy, and heavily support family caregivers against burnout.

Mini-Cog English

Mini-Cog®

Instructions for Administration & Scoring

ID: _____ Date: _____

Step 1: Three Word Registration

Look directly at person and say, "Please listen carefully. I am going to say three words that I want you to repeat back to me now and try to remember. The words are [select a list of words from the versions below]. Please say them for me now." If the person is unable to repeat the words after three attempts, move on to Step 2 (clock drawing).

The following and other word lists have been used in one or more clinical studies.¹⁻³ For repeated administrations, use of an alternative word list is recommended.

Version 1	Version 2	Version 3	Version 4	Version 5	Version 6
Banana	Leader	Village	River	Captain	Daughter
Sunrise	Season	Kitchen	Nation	Garden	Heaven
Chair	Table	Baby	Finger	Picture	Mountain

Step 2: Clock Drawing

Say: "Next, I want you to draw a clock for me. First, put in all of the numbers where they go." When that is completed, say: "Now, set the hands to 10 past 11."

Use preprinted circle (see next page) for this exercise. Repeat instructions as needed as this is not a memory test. Move to Step 3 if the clock is not complete within three minutes.

Step 3: Three Word Recall

Ask the person to recall the three words you stated in Step 1. Say: "What were the three words I asked you to remember?" Record the word list version number and the person's answers below.

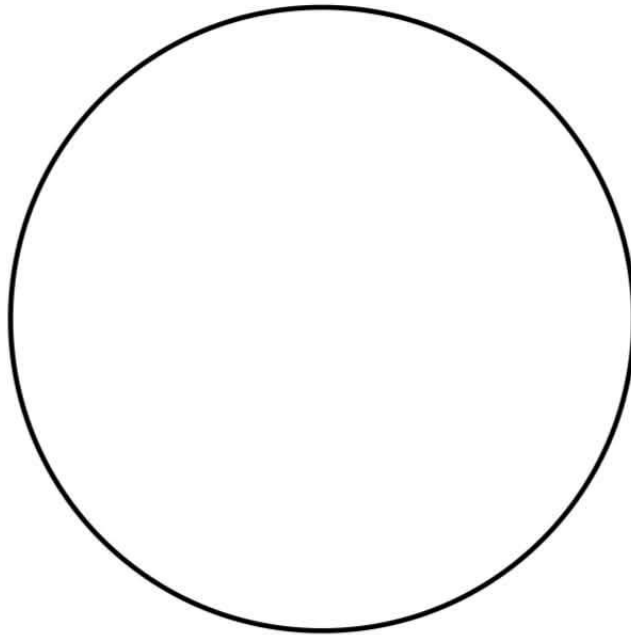
Word List Version: _____ Person's Answers: _____

Scoring

Word Recall: _____ (0-3 points)	1 point for each word spontaneously recalled without cueing.
Clock Draw: _____ (0 or 2 points)	Normal clock = 2 points. A normal clock has all numbers placed in the correct sequence and approximately correct position (e.g., 12, 3, 6 and 9 are in anchor positions) with no missing or duplicate numbers. Hands are pointing to the 11 and 2 (11:10). Hand length is not scored. Inability or refusal to draw a clock (abnormal) = 0 points.
Total Score: _____ (0-5 points)	Total score = Word Recall score + Clock Draw score. A cut point of <3 on the Mini-Cog™ has been validated for dementia screening, but many individuals with clinically meaningful cognitive impairment will score higher. When greater sensitivity is desired, a cut point of <4 is recommended as it may indicate a need for further evaluation of cognitive status.

Clock Drawing

ID: _____ Date: _____



References

1. Borson S, Scanlan JM, Chen PJ et al. The Mini-Cog as a screen for dementia: Validation in a population based sample. *J Am Geriatr Soc* 2003;51:1451–1454.
2. Borson S, Scanlan JM, Watanabe J et al. Improving identification of cognitive impairment in primary care. *Int J Geriatr Psychiatry* 2006;21: 349–355.
3. Lessig M, Scanlan J et al. Time that tells: Critical clock-drawing errors for dementia screening. *Int Psychogeriatr*. 2008 June; 20(3): 459–470.
4. Tsoi K, Chan J et al. Cognitive tests to detect dementia: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Intern Med*. 2015; E1-E9.
5. McCarten J, Anderson P et al. Screening for cognitive impairment in an elderly veteran population: Acceptability and results using different versions of the Mini-Cog. *J Am Geriatr Soc* 2011; 59: 309-213.
6. McCarten J, Anderson P et al. Finding dementia in primary care: The results of a clinical demonstration project. *J Am Geriatr Soc* 2012; 60: 210-217.
7. Scanlan J & Borson S. The Mini-Cog: Receiver operating characteristics with the expert and naive raters. *Int J Geriatr Psychiatry* 2001; 16: 216-222.

Mini-Cog Tagalog

Mini-Cog®

Mga Tagubilin para sa Pangangasiwa at Pagpupuntos

ID: _____ Petsa: _____

Hakbang 1: Pagrehistro sa Tatlong Salita

Tumingin nang tuwid sa tao at sabihin, "Pakisuyong makinig nang mabuti. May sasabihin akong tatlong salitang nais kong ulitin ninyo sa akin ngayon at subukang tandaan. Ang mga salita ay [pumili sa listahan ng mga salita mula sa mga bersyon sa ibaba]. Pakisabi ang mga iyon sa akin ngayon." Kung hindi maulit ng tao ang mga salita matapos ang tatlong pagsubok, lumipat sa Hakbang 2 (pagguhit ng orasan).

Ang sumusunod at ibang mga listahan ng salita ay nagamit na sa isa o higit pang klinikal na pag-aaral.¹⁻³ Para sa nauulit na pangangasiwa, inirerekomenda ang paggamit ng alternatibong listahan ng salita.

Bersyon 1	Bersyon 2	Bersyon 3	Bersyon 4	Bersyon 5	Bersyon 6
Saging	Pinuno	Nayon	Ilog	Kapitan	Anak
Umaga	Panahon	Kusina	Bansa	Hardin	Langit
Upuan	Mesa	Sanggol	Daliri	Litrato	Bundok

Hakbang 2: Pagguhit ng Orasan

Sabihing: "Sunod, nais kong gumuhit ka ng orasan para sa akin. Una, ilagay ang lahat ng numero kung saan dapat nakapwesto ang mga ito." Kapag kumpleto na iyon, sabihing: "Ngayon, ilagay ang mga kamay sa 10 minuto makalipas ang 11."

Gamitin ang paunang nilimbag na bilog (tingnan ang susunod na pahina) para sa gawaing ito. Ulitin ang mga tagubilin hangga't kailangan dahil hindi ito pagsusulit sa pagkakabisa.

Lumipat sa Hakbang 3 kung hindi makukumpleto ang orasan sa loob ng tatlong minuto.

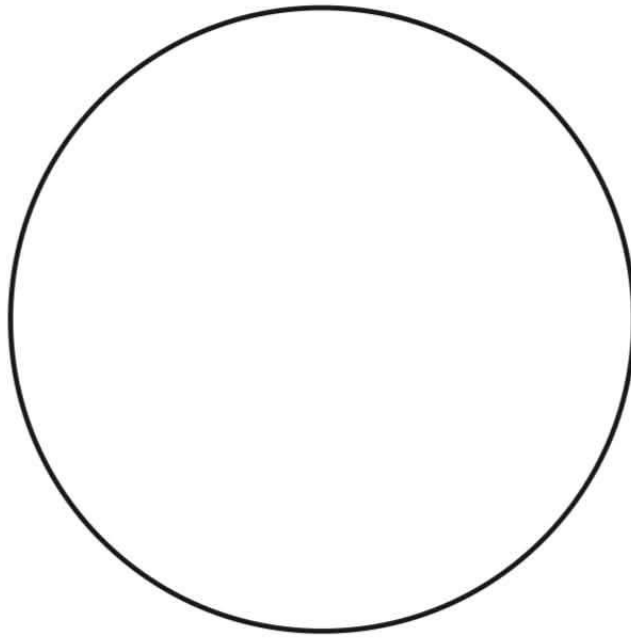
Hakbang 3: Pag-alala sa Tatlong Salita

Hilingin sa tao na alalahanin ang tatlong salitang sinabi mo sa Hakbang 1. Sabihin: "Ano ang tatlong salitang sinabi kong tandaan mo?" Itala ang numero ng bersyon ng listahan ng salita at ang sagot ng tao sa ibaba.

Bersyon ng Listahan ng Salita: _____ Mga Sagot ng Tao: _____

Pagpupuntos

Pag-alala sa Salita: _____ (0-3 puntos)	1 puntos para sa bawat salitang kusang naalala nang hindi binibigyan ng palatandaan.
Pagguhit ng Orasan: _____ (0 o 2 puntos)	Normal na orasan = 2 puntos. Ang normal na orasan ay mayroon ng lahat ng numero sa wastong pagkakasunod-sunod at humigit-kumulang tamang posisyon (hal., ang 12, 3, 6 at 9 ay nasa angklang posisyon) nang walang nawawala o magkaparehong mga numero. Ang mga kamay ay nakaturo sa 11 at 2 (11:10). Hindi binibigyan ng puntos ang haba ng kamay. Kawalang kakayahan o pagtangging gumuhit ng orasan (hindi normal) = 0 puntos
Kabuuang Puntos: _____ (0-5 puntos)	Kabuuang puntos = puntos sa Pag-alala sa Salita + puntos sa Pagguhit ng Orasan. Ang cut point na <3 sa Mini-Cog™ ay napatotohanan para sa pagsasala para sa dementia, ngunit makakakuha ng mas mataas na puntos ang maraming indibidwal na may klinikal na makabuluhang kapansanan sa pag-unawa. Kung nais ng higit pang pagkasensitibo, inirerekomenda ang cut point na <4 dahil maaari itong magpakita ng pangangailangan sa karagdagangpagsuri sa kalagayan sa pag-unawa.



Mga Sangguhian

1. Borson S, Scanlan JM, Chen PJ et al. The Mini-Cog as a screen for dementia: Validation in a population based sample. J Am Geriatr Soc 2003;51:1451–1454.
2. Borson S, Scanlan JM, Watanabe J et al. Improving identification of cognitive impairment in primary care. Int J Geriatr Psychiatry 2006;21: 349–355.
3. Lessig M, Scanlan J et al. Time that tells: Critical clock-drawing errors for dementia screening. Int Psychogeriatr. 2008 June; 20(3): 459–470.
4. Tsoi K, Chan J et al. Cognitive tests to detect dementia: A systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2015; E1-E9.
5. McCarten J, Anderson P et al. Screening for cognitive impairment in an elderly veteran population: Acceptability and results using different versions of the Mini-Cog. J Am Geriatr Soc 2011; 59: 309-213.
6. McCarten J, Anderson P et al. Finding dementia in primary care: The results of a clinical demonstration project. J Am Geriatr Soc 2012; 60: 210-217.
7. Scanlan J & Borson S. The Mini-Cog: Receiver operating characteristics with the expert and naive raters. Int J Geriatr Psychiatry 2001; 16: 216-222.

Lawton's IADLs Test English

Patient Name: _____ Date: _____
 Patient ID # _____

LAWTON - BRODY INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING SCALE (I.A.D.L.)			
Scoring: For each category, circle the item description that most closely resembles the client's highest functional level (either 0 or 1).			
A. Ability to Use Telephone		E. Laundry	
1. Operates telephone on own initiative-looks up and dials numbers, etc.	1	1. Does personal laundry completely	1
2. Dials a few well-known numbers	1	2. Launders small items-rinses stockings, etc.	1
3. Answers telephone but does not dial	1	3. All laundry must be done by others	0
4. Does not use telephone at all	0		
B. Shopping		F. Mode of Transportation	
1. Takes care of all shopping needs independently	1	1. Travels independently on public transportation or drives own car	1
2. Shops independently for small purchases	0	2. Arranges own travel via taxi, but does not otherwise use public transportation	1
3. Needs to be accompanied on any shopping trip	0	3. Travels on public transportation when accompanied by another	1
4. Completely unable to shop	0	4. Travel limited to taxi or automobile with assistance of another	0
		5. Does not travel at all	0
C. Food Preparation		G. Responsibility for Own Medications	
1. Plans, prepares and serves adequate meals independently	1	1. Is responsible for taking medication in correct dosages at correct time	1
2. Prepares adequate meals if supplied with ingredients	0	2. Takes responsibility if medication is prepared in advance in separate dosage	0
3. Heats, serves and prepares meals, or prepares meals, or prepares meals but does not maintain adequate diet	0	3. Is not capable of dispensing own medication	0
4. Needs to have meals prepared and served	0		
D. Housekeeping		H. Ability to Handle Finances	
1. Maintains house alone or with occasional assistance (e.g. "heavy work domestic help")	1	1. Manages financial matters independently (budgets, writes checks, pays rent, bills, goes to bank), collects and keeps track of income	1
2. Performs light daily tasks such as dish washing, bed making	1	2. Manages day-to-day purchases, but needs help with banking, major purchases, etc.	1
3. Performs light daily tasks but cannot maintain acceptable level of cleanliness	1	3. Incapable of handling money	0
4. Needs help with all home maintenance tasks	1		
5. Does not participate in any housekeeping tasks	0		
Score		Score	
		Total score _____	
A summary score ranges from 0 (low function, dependent) to 8 (high function, independent) for women and 0 through 5 for men to avoid potential gender bias.			

Source: try this: Best Practices in Nursing Care to Older Adults, The Hartford Institute for Geriatric Nursing, New York University, College of Nursing, www.hartfordnign.org.

MeinaHealth

Lawton's IADLs Test Tagalog

THE LAWTON INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING (IADL) SCALE

(Supplemental 2)

Subject ID No. _____

Subject's Initials: _____

Date of Test: ____ / ____ / ____

Examiner's Initials: _____

Kakayahang Gumamit ng Telepono 1. Nagkukusang gumamit ng telepono; nahahanap at naida-dial ang tamang numero ng taong tatawagan 2. Naida-dial ang ilang pamilyar na numero na tatawagan 3. Nakakasagot ng telepono 4. Hindi na nakakagamit ng telepono	Kakayahang Maglaba 1. Kayang maglaba ng mga sariling damit. 2. Kayang maglaba at magbanlaw ng ilang mga maliliit at piling kasuotan tulad ng medyas, stockings, atbp. 3. Lahat ng damit ay kailangang ipalaba sa ibang tao.
Kakayahang Mamili 1. Kayang mangasiwa ng lahat ng mga kailangang bilhing gamit ng iba. 2. Kayang mamimili ng ilang mga piling gamit. 3. Kinakailangang gabayan at samahan tuwing namimili. 4. Wala nang kakayahang mamili.	Kakayahang Paglalakbay 1. May kakayahang maglakbay mag-isa gamit ang pampublikong sasakyan o nagmamamango ng sariling sasakyan 2. Kayang mag-taxi mag-isa ngunit hindi gumagamit ng iba pang pampublikong sasakyan 3. Kaya lamang maglakbay kung magtataxi o gagamit ng pribadong sasakyan 4. Kaya lamang ...* 5. Walang nang kakayahang maglakbay.
Kakayahang Maghanda ng Pagkain 1. Nagpapalano, naghahanda at naghahain ng tamang pagkain nang mag-isa. 2. Kayang maghanda ng sapat na pagkain kapag may nakahandang sangkap. 3. Kayang mag-init, maghanda at maghain ng pagkain ngunit walang kakayahang suriin ang nutrisyon ng pagkain. 4. Kinakailangang paghainan ng pagkain.	Pangagasiwa sa Pansariling Medikasyon 1. Pinapangasiwaan ang sariling pag-inom ng gamot 2. Kusang umiinom ng naihandang gamot. 3. Wala nang kakayahang uminom ng sariling gamot.
Kakayahang Gumawa ng Gawaing Bahay 1. Kakayahang panatilihin ng malinis ang bahay na may katulong paminsan-minsan tulad ng paghuhugas ng pinggan, 2. Kayang gumawa ng magagaang trabaho ngunit hindi kayang panatilihin ang sapat na linis 3. Kailangan ng tulong sa lahat ng gawaing bahay 4. Hindi na gumagawa ng kahit anong gawaing bahay.	Kakayahang Mangasiwa ng mga Gastusin 1. Kakayahang pamahalaan ang mga pinansyal na bagay nang mag-isa tulad ng pag-badyet ng pera, 2. Pagsulat ng cheke, pagbayad ng renta, pagpunta sa banko) pati na ang pagkolekta at pagsubaybay ng kita 3. Napapamahalaan ang pang-araw araw na gastusin ngunit nangangailangan ng tulong sa mga transaksyon sa banko at mga malalaking bilihin 4. Wala nang kakayahang humawak ng pera.

Administration Instructions (Mga Tagubilin sa Pagsasagawa)

English	Tagalog
Observe or Interview: Evaluate the patient by observing their daily routine or by interviewing them, their family members, or primary caregivers.	Mag-observerba o Magtanong: Suriin ang pasyente sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanilang kilos o pagtatanong sa kanila, sa pamilya, o sa kanilang tagapag-alaga.
Rate Current Ability: Score the patient based on their actual performance over the past 24 to 48 hours, not their potential ability.	Ibase sa Kasalukuyang Kakayahan: Bigyan ng marka ang pasyente ayon sa aktwal nilang ginawa sa nakalipas na 24 hanggang 48 oras, hindi sa kung ano ang "kaya" lang nilang gawin.
Apply Strict Scoring: Award 1 point ONLY if the patient performs the task completely independently. Award 0 points if they require any form of human assistance, supervision, or verbal prompting.	Maging Mahigpit sa Pagpuntos: Magbigay ng 1 puntos KUNG KAYA LANG nilang gawin ang buong aktibidad nang mag-isa. Magbigay ng 0 puntos kung kailangan nila ng anumang tulong, gabay, o paalala mula sa ibang tao.

Mini-Cog & Lawton IADL Integrated Interpretation Matrix

Mini-Cog Score (Cognitive Risk)	Lawton IADL Score (Functional Support Needs)	Overall Clinical Interpretation (Bilingual)	Action & Recommended Referral (Bilingual)
3 to 5 Points (Low Risk)	Full Score (8/8 for Women, 5/5 for Men)	EN: Low Risk / Independent No current indicators of major memory problems; fully capable of managing complex daily tasks independently. FIL: Mababang Panganib / Malaya Walang nakikitang malaking problema sa memorya sa ngayon; kayang-kaya mag-isa ang mga gawaing-bahay at personal na buhay.	EN: Home Monitoring Encourage healthy aging habits. Re-screen in 12 months, or sooner if the family notices sudden behavioral changes. FIL: Karaniwang Pagsubaybay Ipagpatuloy ang malusog na pamumuhay. Ulitin ang test paglipas ng isang taon, o mas maaga kung may mapansing biglang pagbabago.
3 to 5 Points (Low Risk)	Partial Impairment (Struggles with 2 to 4 tasks)	EN: Isolated Functional Support Need Mental clarity appears steady, but the patient struggles with specific independent daily tasks (e.g., struggles with using the phone or cooking safely). FIL: Kailangan ng Tulong sa Gawaing-Bahay Maayos ang takbo ng isip, ngunit nahihirapan sa ilang partikular na gawain (hal. paggamit ng telepono o ligtas na pagluluto).	EN: Home Safety & Task Assistance Assign a family member to supervise or assist with the difficult tasks. Schedule a routine check-up with a Family Physician to rule out general physical weakness or joint pain. FIL: Pag-alalay at Kaligtasan sa Bahay Magtalaga ng kapamilya na tutulong sa mga gawaing nahihirapan siya. Dalhin sa Family Doctor para masuri kung may panlalata o pananakit ng kasukasan.
3 to 5 Points (Low Risk)	Severe Impairment (Struggles with 5 or more tasks)	EN: Severe Physical/Functional Limitations Cognitive skills test within the low-risk range, but the patient has a severe loss of independent capabilities due to heavy physical limitations. FIL: Malubhang Limitasyon sa Kilos Maayos ang lagay ng isip base sa test, ngunit hindi na kayang kumilos mag-isa dahil sa malubhang pisikal na karamdaman o panghihina.	EN: Primary Care Review & Caregiver Setup Consult a Family Physician or General Internist immediately to address physical mobility or chronic illness. Organize persistent daily help at home to prevent accidents. FIL: Konsulta sa Doktor at Pag-ayos ng Tagapag-alaga Ipatingin agad sa Family Doctor o Internist para magamot ang pisikal na panghihina. Ayusin ang iskedyul ng pamilya para may laging kasama ang pasyente sa bahay upang maiwasan ang sakuna.
0 to 2 Points (High Risk)	Full Score (8/8 for Women, 5/5 for Men)	EN: Early Cognitive Risk (High Alert) The test flags a high risk for memory or thinking problems,	EN: Specialist Diagnostic Evaluation Schedule an appointment with a Neurologist or Geriatrician for a

		even though the patient is currently managing daily chores without making noticeable mistakes. FIL: Maagang Panganib sa Memorya Mataas ang babala na may problema sa memorya o pag-iisip, kahit na sa ngayon ay nagagawa pa naman niya ang mga gawaing-bahay nang walang mali.	formal medical assessment. Do not wait for daily functioning to decline before seeking a professional opinion. FIL: Patingin sa Espesyalistang Doktor Magpa-iskedyul agad ng patingin sa isang Neurologist o Geriatrician para sa pormal na pagsusuri. Huwag nang hintaying hindi niya makuha ang mga gawaing-bahay bago magpakonsulta.
0 to 2 Points (High Risk)	Partial Impairment (Struggles with 2 to 4 tasks)	EN: Cognitive Decline with Daily Struggles High risk of progressive memory loss (such as early-stage dementia) that is actively interfering with their ability to live safely and manage household responsibilities alone. FIL: Pagkaulianin na may Kahirapan sa Gawain Mataas ang posibilidad ng lumalalang pagkaulianin (tulad ng maagang yugto ng dementia) na kasalukuyan nang nakakaapekto sa ligtas at malayang pamumuhay mag-isa.	EN: Urgent Medical Workup & Safety Safeguards Immediate referral to a Neurologist or Geriatrician. The family must step in immediately to take control of patient medications and financial management to prevent critical errors. FIL: Agarang Patingin at Ligtas na Pamamahala Ipatingin agad sa Neurologist o Geriatrician. Kailangan nang makialam ng pamilya sa pagpapainom ng gamot at paghawak ng pera ng pasyente upang maiwasan ang mapanganib na pagkakamali.
0 to 2 Points (High Risk)	Severe Impairment (Struggles with 5 or more tasks)	EN: Advanced Cognitive & Functional Decline Indicators point toward an advanced state of confusion or memory loss paired with a complete loss of ability to manage daily living tasks without full support. FIL: Malubhang Pagkaulianin at Panghihina Malinaw ang mga senyales ng malubhang pagkalito o pagkawala ng memorya, kasabay ng tuluyang kawalan ng kakayahang mamuhay nang walang nag-aalaga.	EN: Comprehensive Geriatric Care & Family Support Seek urgent guidance from a specialized Memory Clinic or Geriatric Medical Team. Establish round-the-clock family supervision, secure home safety modifications, and connect the primary family caregiver with community support groups to prevent psychological burnout. FIL: Buong Alaga at Suporta sa Pamilya Humingi ng agarang tulong sa isang Memory Clinic o pangkat ng mga Geriatrician. Magtalaga ng 24/7 na magbabantay, ayusin ang bahay upang maiwasan ang dulas o tumba, at humanap ng suporta para sa nag-aalaga upang maiwasan ang labis na pagkapagod at stress.